

Медицинское консультационное заключение

Информация о пациенте

- **ФИО пациента:** Барахтенко Егор Андреевич (р. 1)
- **Пол:** Мужской (р. 1)
- **Дата рождения:** 24 апреля 2008 г. (р. 1)
- **Диагноз:** Рефрактерный вторичный острый миелоидный лейкоз (р. 1)

Оценка текущего состояния заболевания

В ноябре 2024 года у пациента был диагностирован миелодиспластический синдром (МДС) с мутацией NRAS и высокой экспрессией WT1 (р. 1). После первоначального лечения в апреле 2025 года пациенту провели первую аллогенную трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток от неродственного донора, что привело к кратковременной ремиссии (р. 1). В июле 2025 года заболевание трансформировалось во вторичный острый миелоидный лейкоз (вОМЛ) с мутациями/высокой экспрессией FLT3-ITD, WT1 и BAALC (р. 1). В сентябре 2025 года пациент получил вторую гаплоидентичную трансплантацию от отца, но столкнулся с ранним рецидивом (р. 1). Последующие линии таргетной терапии, химиотерапии и инфузии донорских лимфоцитов (DLI) оказались неэффективными (р. 1). В апреле 2026 года пациент получил терапию CAR-NK клетками против CD33, однако болезнь быстро прогрессировала: бласты в костном мозге достигли 71%, МОБ (минимальная остаточная болезнь) — 51.2%, бласты в периферической крови — 35% (р. 1). В настоящее время состояние пациента осложнено двусторонней многоуровневой смешанной легочной инфекцией, острым повреждением почек, гнойным средним отитом и пансинуситом при крайне низком соматическом статусе (р. 1). Это представляет собой терминальную стадию рефрактерного лейкоза, и все стандартные радикальные методы лечения исчерпаны (р. 1).

Консультация врача

У данного пациента наблюдается вторичный острый миелоидный лейкоз, трансформировавшийся из МДС, сопровождающийся мутациями высокого риска, такими как FLT3-ITD, что представляет собой подтип с чрезвычайно высокой степенью злокачественности и агрессивности (р. 1). Несмотря на проведение нескольких высокоинтенсивных режимов лечения, включая две трансплантации и CAR-NK-клеточную терапию, у пациента развился быстрый рецидив, что указывает на высокую лекарственную устойчивость и пролиферативную активность опухолевого клона (р. 1). Кроме того, у пациента имеются сопутствующие нарушения функции почек и тяжелая легочная инфекция, что говорит о низком органном резерве и плохой переносимости лечения (р. 1). Это крайне опасная, быстро прогрессирующая критическая стадия (р. 1). Необходимо как можно скорее применить щадящий, но точный индивидуализированный подход к лечению, иначе состояние пациента продолжит стремительно ухудшаться (р. 1).

У пациента тяжелейшая форма рефрактерного ОМЛ, рецидивировавшего после двух трансплантаций (р. 1). Общее состояние критическое, осложненное почечной недостаточностью и активной легочной инфекцией (р. 1). Стандартных методов

радикального лечения не осталось, однако сохраняется возможность проведения индивидуализированной противорецидивной (сальважной) терапии (р. 1). Прежде всего необходимо уточнить соматический статус пациента, последние показатели функции почек и степень контроля легочной инфекции (р. 1). Если физическое состояние пациента позволяет совершить поездку в клинику, будет проведена систематическая оценка и комплексное тестирование на генные мутации (р. 1). На основании результатов тестов будут подобраны наиболее подходящие и безопасные индивидуальные таргетные препараты (р. 1). При необходимости может быть добавлена терапия антителами для контроля заболевания, облегчения симптомов и максимального продления жизни при одновременной защите функций органов и лечении инфекции (р. 1). Рекомендуется как можно скорее провести онлайн-консультацию в Zoom, чтобы врач мог точно оценить статус пациента в режиме реального времени, избежать задержек в лечении и не упустить критическое терапевтическое окно (р. 1).

План лечения

Фаза I: Точная повторная оценка при поступлении

1. Комплексная оценка соматического статуса, симптомов, риска кровотечений и риска инфекции (р. 2).
2. Повторный развернутый анализ крови (ОАК), биохимия, почечная функция, электролиты и скорость клубочковой фильтрации (СКФ) (р. 2).
3. КТ органов грудной клетки, воспалительные маркеры и этиологическое исследование для оценки контроля легочной инфекции (р. 2).
4. Аспирация костного мозга, иммунофенотипирование, мониторинг МОБ и комплексный скрининг генных мутаций (полногеномное тестирование) (р. 2).
5. Оценка функции сердца, коагулограмма и предтрансфузионные лабораторные анализы (р. 2).

Фаза II: Базовая противорецидивная (сальважная) терапия

1. На основе результатов тестирования генных мутаций — подбор наиболее безопасной и подходящей таргетной терапии (р. 2).
2. На основе иммунофенотипа и клинических потребностей — сочетание с препаратами антител для синергетического лечения при необходимости (р. 2).
3. Основные приоритеты — защита функции почек, контроль легочной инфекции и стабилизация функций внутренних органов (р. 2).
4. Комплексная поддерживающая терапия на протяжении всего лечения: гемопозитическая поддержка, антиинфекционная терапия, инфузионная терапия и облегчение симптомов (р. 2).
5. Регулярный мониторинг эффективности лечения и показателей безопасности, динамическая коррекция режима терапии по мере необходимости (р. 2).

Фаза III: Последующее лечение

- **Сроки:** Будут определены в зависимости от ответа на лечение Фазы II (р. 2).

- **Стоимость:** Оценивается отдельно в соответствии с состоянием пациента, ответом на лечение и возможными осложнениями (р. 2).
- Разработка плана последующего лечения на основе эффективности Фазы II, статуса контроля заболевания и восстановления функций органов (р. 2); при необходимости — проведение консолидирующей/поддерживающей терапии, поддерживающего и симптоматического ухода, а также долгосрочного контроля инфекций (р. 3).
Динамический мониторинг статуса болезни и качества жизни с соответствующей корректировкой общей стратегии (р. 3).

Расчетная продолжительность и стоимость лечения

(На основе обменного курса 1 USD = 7 RMB; окончательная стоимость будет рассчитана по фактическому курсу на момент поступления. Больничные сборы рассчитываются в RMB) (р. 3)

Лечебная процедура	Расчетное время	Элементы	Оценка стоимости (RMB)	Оценка стоимости (USD)
Шаг 1. Оценка Предварительное обследование перед лечением (специальные анализы крови и визуализирующие исследования) (р. 3)	7 дней (р. 3)	Генетическое и молекулярное тестирование, анализы аспирата костного мозга (морфология, проточная цитометрия, мутации генов, хромосомный тест, биопсия костного мозга и т.д.) (р. 3). Люмбальная пункция (включая проточную цитометрию спинномозговой жидкости) (р. 3). Анализ крови	105 000 – 140 000 (р. 3)	15 000 – 20 000 (р. 3)

Лечебная процедура	Расчетное время	Элементы	Оценка стоимости (RMB)	Оценка стоимости (USD)
		(включая биохимический тест, показатели инфекций) (р. 3). Оценка тромбообразования и риска кровотечений (р. 3). ПЭТ-КТ, КТ легких (опционально), ЭхоКГ, УЗИ брюшной полости, МРТ головного мозга, ЭКГ, минимальная остаточная болезнь, предтрансплантационный скрининг (pp. 3-4).		
Шаг 2. Базовая противорецидивная терапия (Таргетная терапия + иммуномодуляция + терапия антителами) (р.	2–4 недели (р. 4)	Таргетная терапия, иммуномодулирующая терапия, таргетная терапия антителами, поддерживающ	210 000 – 420 000 (р. 4)	30 000 – 60 000 (р. 4)

Лечебная процедура	Расчетное время	Элементы	Оценка стоимости (RMB)	Оценка стоимости (USD)
4)		ий уход, купирование осложнений (р. 4).		
Общая госпитализация (р. 4)	3–5 недель (р. 4)	Другие расходы, включая стандартную одноместную палату, оплату услуг медсестер, консультации, лечебные процедуры и т.д. (р. 4)	70 000 (р. 4)	10 000 (р. 4)
Итоговая сумма (включая Шаги 1 и 2) (р. 4)	3–5 недель (р. 4)	Все вышеперечисленное (р. 4)	385 000 – 630 000 (р. 4)	55 000 – 90 000 (р. 4)

Шаг 3. Последующее лечение

Разработка последующего плана на основе результатов Шага 2, контроля болезни и восстановления органов (р. 4). При необходимости — поддерживающий уход и долгосрочный контроль инфекций (р. 4).

Вышеуказанные расходы рассчитаны примерно на основе текущего физического состояния. По мере развития заболевания план и стоимость могут меняться (р. 4).

В стоимость включено:

1. Размещение в одноместной палате (р. 4).
2. Все необходимые анализы и тесты согласно плану лечения (р. 4).
3. Медикаменты, клеточная иммунотерапия и другие расходы на лечение в соответствии с планом (р. 4).
4. Рутинные медицинские услуги, консультации врачей, осмотры, лабораторные

анализы и т.д (р. 4).

В оплату НЕ включено:

1. Питание (р. 4).
2. Препараты, выдаваемые при выписке (р. 4).
3. Непредвиденное лечение и обследования (при угрожающих жизни инфекциях, тяжелых побочных эффектах или расходы на ОРИТ/реанимацию) (рр. 4-5).
4. Лечение сопутствующих заболеваний, не связанных с основным диагнозом (р. 5).
5. Непредвиденные экстренные ситуации (р. 5).
6. Личные расходы (телефонные звонки, авиабилеты) (р. 5).

Условия оплаты:

- **Первоначальный депозит:** При поступлении в больницу требуется минимальный первоначальный депозит в размере 40 000 USD (эквивалент 280 000 RMB) (р. 5). Этот депозит будет зачтен в счет общей расчетной стоимости лечения (р. 5).
- **Окончательный расчет:** Оставшаяся сумма подлежит оплате по завершении лечения (р. 5). Любые дополнительные расходы, понесенные в процессе, будут добавлены к окончательному платежу, а неиспользованные средства из первоначального депозита будут возвращены (р. 5).

Важные соображения перед началом лечения

Учитывая, что у пациента терминальная стадия рефрактерного ОМЛ с рецидивом после двух трансплантаций и неэффективностью нескольких линий терапии, осложненная почечной недостаточностью и легочной инфекцией, состояние является крайне критическим (р. 5). Каждый день промедления может привести к потере любого шанса на лечение (р. 5). Функция почек и контроль легочной инфекции являются ключевыми факторами, определяющими возможность проведения терапии (р. 5).

Пожалуйста, как можно скорее предоставьте самые последние результаты анализов функции почек, статуса легочной инфекции и общего соматического статуса, а также организуйте немедленную онлайн-консультацию в Zoom для прямой оценки лечащим врачом (р. 5). Это позволит одновременно определить, может ли пациент быть госпитализирован и доступны ли подходящие медикаменты, что обеспечит быструю оценку наличия терапевтического окна (р. 5).

Ввиду сложности заболевания настоятельно рекомендуется запланировать индивидуальную онлайн-консультацию с директором отделения гематологии, доктором Чжао Дэфэнгом (Zhao Defeng), который имеет обширный опыт лечения рефрактерного вторичного острого миелоидного лейкоза (р. 5).

Эта бесплатная консультация по предварительной записи предоставит:

1. Подробную оценку текущего состояния (р. 5).
2. Предварительные рекомендации по лечению, адаптированные к вашим

потребностям (р. 5).

3. Возможность напрямую задать важные вопросы старшему специалисту (р. 5).

Для иностранных пациентов консультация предоставляется **бесплатно** (р. 5). Перевод на английский язык предоставляется бесплатно (р. 5). Для других языков может быть организован профессиональный перевод по запросу (100 USD за 30 минут), либо вы можете пригласить своего переводчика (pp. 5-6). Настоятельно рекомендуется провести дистанционную консультацию как можно скорее, чтобы избежать задержек в планировании лечения и графике забора клеток (р. 6).

Важные примечания

1. Вышеуказанный предварительный план основан на предоставленной информации (р. 6). При поступлении в стационар будет проведена комплексная повторная оценка (р. 6). В случае существенных расхождений с ранее представленными данными план и стоимость могут быть скорректированы после обсуждения с пациентом и/или законным представителем (р. 6).
2. **За одну неделю до поступления** необходимо предоставить свежие отчеты о внешних лабораторных исследованиях и общем состоянии пациента, такие как (р. 6):
 - Общий анализ крови (ОАК) за последнюю неделю для оценки миелосупрессии или риска инфекции (р. 6).
 - Показатели функции печени, почек и сердца, чтобы убедиться, что пациент перенесет химиотерапию (р. 6).
 - Статус контроля инфекций для подтверждения отсутствия тяжелого инфекционного процесса (р. 6).
 - Оценка физического состояния, особенно на предмет симптомов РТПХ (реакция «трансплантат против хозяина») (р. 6).
 - Данные о группе крови и резус-факторе для подготовки к использованию донорских клеток во время лечения (р. 6).

Клиника предоставляет многоязычную поддержку, учитывает культурные особенности, предлагает персонализированное питание, помощь в размещении и транспортировке, а также услуги сопровождения членов семьи (р. 6). Наша международная команда по обслуживанию пациентов будет сопровождать вас на протяжении всего процесса — от встречи в аэропорту и госпитализации до выздоровления и последующего наблюдения (р. 6).

Директор отделения гематологии: Чжао Дэфэн (Zhao Defeng) (р. 6)

Больница Гобоу Божэнь в Пекине (GoBroad Boren Hospital of Beijing) (р. 6)

Дата: 12 мая 2026 г. (р. 6)

Дисклеймер: Предоставленная информация носит ознакомительный характер, основана на медицинских документах сторонней клиники и не является окончательным диагнозом или прямым руководством к действию. Любые медицинские решения, включая поездки и участие в лечебных программах, должны приниматься строго под

контролем квалифицированных лечащих врачей.

Если вам необходимо подготовить **ответное письмо в клинику**, уточнить **список документов** для перевода или составить **вопросы для доктора Чжао** к предстоящей Zoom-консультации, пожалуйста, сообщите об этом.